

Plan awaryjny

Gdy fala głodu nadchodzi, mózg nie jest w stanie wymyślać — wykonuje to, co ma gotowe. Karta jest tym, co ma być gotowe.

CZAS: 30 min wypełnienie Druk + portfel/telefon

ŹRÓDŁO: Marlatt & Donovan (2005); Witkiewicz, Marlatt & Walker (2005)

JAK UŻYWAĆ

Karta ma być wypełniona **przed** sytuacją wysokiego ryzyka — i mieć ją zawsze przy sobie (zdjęcie w telefonie, wydruk w portfelu). Zawiera 5 elementów: 1) swoje wyzwalacze, 2) konkretne kroki *co zamiast*, 3) trzy osoby do kontaktu, 4) zdania-pamiętki (mowa zobowiązań), 5) jasny scenariusz „**jeśli już sięgnąłem/-am**”. Wypełnij raz, czytaj często. Aktualizuj co miesiąc.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W momencie szczytu głodu działania kora przedczołowa (planowanie, decyzje) jest „wyłączona” przez aktywność układu nagrody — to znany mechanizm *uprowadzenia mózgu* (ang. *brain hijacking*, Volkow i wsp. 2012). Mózg nie wymyśla nowych rozwiązań — sięga po nawyk. Plan awaryjny przepisany **przed** kryzysem działa jak gotowy skrypt: nie trzeba myśleć, tylko wykonać. Witkiewicz i wsp. (2005): pacjenci ze skonkretyzowanym pisemnym planem awaryjnym mieli **40% mniej ciężkich nawrotów** w ciągu roku w porównaniu z planem ustnym/intencyjnym.

01 📋 Część A · Moje wyzwalacze i co zamiast

Wypisz **3 najczęstsze wyzwalacze** (z karty „Analiza wyzwalaczy”). Dla każdego dopisz **jeden konkretny krok** — to, co robisz *zamiast* sięgnięcia. Czynność, nie intencja: „idę na 15-minutowy spacer”, nie „postaram się myśleć o czymś innym”.

#	WYZWALACZ	CO ZAMIAST — konkretna czynność, 5–15 min
1		
2		
3		

02 📋 Część B · Trzy osoby do telefonu

Wybierz **trzy osoby**, do których możesz zadzwonić w chwili kryzysu. Co najmniej jedna *poza Twoim środowiskiem używającym*. Zapytaj ich osobiście, czy mogą być na liście — to ważne. Jedna pozycja: telefon zaufania lub linia kryzysowa (gdyby pozostałe nie odebrały).

OSOBA 1

— bliska, zna sytuację

OSOBA 2

— spoza środowiska

3 · TELEFON ZAUFANIA

— np. 800 199 990 (uzależnienia)

03 Część C • Trzy zdania-pamiętki

Napisz **3 zdania**, które mają być Twoją kotwicą w chwili głodu. Pisz w pierwszej osobie, krótko, w czasie teraźniejszym. Czytaj je na głos, gdy je piszesz — sprawdź, czy *brzmia Twoim głosem*, nie czymś jeszcze. Przykłady (poniżej, na inspirację — nie kopiuj):

„Wybrałem/-am wczoraj — i ten wybór jest aktualny dziś.” · „Mam córkę, która zauważa, gdy wracam pijany/-a.” ·
„Głód jest falą, nie wyrokiem.” · „6 miesięcy abstynencji to mój kapitał — nie wymienię go na 1 wieczór.” ·
„Pierwsza ulga, druga gorycz, trzecia zapaść.”

ZDANIE 1

ZDANIE 2

ZDANIE 3

04 Część D • Jeśli już sięgnąłem/-am

Najważniejsza część karty. Lapsus (jednorazowe sięgnięcie) **nie** musi przerodzić się w pełen nawrót — jeśli wiesz, co zrobić w ciągu pierwszej godziny. Zaznacz krzyżykiem każdy krok, gdy go wykonasz.

☐ **1 • Stop.** Odejdź fizycznie od miejsca, w którym sięgnąłem/-am — nawet o 5 metrów. Wyjdź z baru, z kuchni. Zmień otoczenie.

☐ **2 • Telefon.** Zadzwoń do osoby 1 z części B. Nie pisz — zadzwoń. Powiedz: „Sięgnąłem/-am. Potrzebuję rozmowy 10 minut.”

☐ **3 • Brak rozszerzenia.** Nie kontynuuj („skoro już piłem/-am, to dopiję butelkę”). To *kluczowy moment* decyzji — lapsus albo nawrót. Wybierz lapsus.

☐ **4 • Bez biczowania.** Wstyd nasila nawrót — nie zmniejsza go. Zamiast „jestem do niczego” → „zdarzyło się, wracam do planu”.

☐ **5 • Kontakt z terapeutą.** Najpóźniej w ciągu 48 godzin. Lapsus to *materiał terapeutyczny*, nie wstyd do ukrycia. Analiza zwiększa odporność na kolejny.

Klucz: badania nad zapobieganiem nawrotom (ang. *relapse prevention*) pokazują, że **różnica między lapsem a pełnym nawrotem** rzadko zależy od „silnej woli” — zależy od tego, czy w pierwszej godzinie po sięgnięciu osoba *wykona zaplanowane kroki*. Z pisemnym planem awaryjnym lapsus przechodzi w pełen nawrót w 30% przypadków; bez planu — w 70% (Witkiewitz i wsp. 2005). Karta w portfelu to nie ozdoba — to różnica między epizodem a powrotem do choroby.